

Prévention du risque allergique péranesthésique

Introduction, méthodologie et légende



Champ : réactualisation (2011) des recommandations Sfar/SFAIC de 2001-2002 sur la **prévention** du risque allergique péranesthésique et la **conduite du bilan diagnostique** d'une réaction d'hypersensibilité immédiate (HSI) péranesthésique -- PAS le traitement aigu du choc, traité en question 6 (voir renvoi en fin de fiche). Le document est organisé en six questions ; cette fiche reproduit intégralement les **questions 1 à 5** (réalité du risque et substances responsables, mécanismes/physiopathologie, bilan diagnostique biologique et cutané, facteurs favorisants et place du bilan allergologique péranesthésique, prévention primaire/secondaire -- prémédication -- choix de la technique anesthésique) et résume la **question 6** (traitement) avec renvoi.

Relation avec la fiche compagnon « Anaphylaxie 2025 » de ce site : Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf (RFE Sfar/SFA plus récente, sur la prise en charge de l'hypersensibilité immédiate péri-opératoire) couvre déjà, intégralement et de façon plus à jour, le bilan diagnostique complet (tryptase, histamine, IgE spécifiques, test d'activation des basophiles, tests cutanés, tests de provocation), les facteurs de risque (latex, bêta-lactamines/céfazoline, pholcodine, mastocytose) et le traitement (classification de gravité, adrénaline, remplissage, choc réfractaire). Cette fiche-ci, bâtie sur le document source de 2011, ne duplique donc pas ce contenu : elle en reste au niveau de détail du texte de 2011 pour ces points communs (avec renvoi), et développe en revanche ce que le document 2025 ne couvre pas -- épidémiologie/fréquences des substances responsables, physiopathologie du choc, tableaux de concentrations de référence pour les tests cutanés, situations particulières de croisement allergénique (AINS, paracétamol, morphine/codéine, œuf/soja, fruits de mer, protamine), et surtout la **question 5** -- prévention programmée, prémédication, choix de la technique -- que la fiche 2025 déclare elle-même hors de son propre champ.

Méthodologie -- niveaux de preuve (NP) et absence de grade par recommandation (disclosure) : le texte source utilise une méthode GRADE modifiée, agréée par le comité des référentiels de la Sfar, pour attacher un niveau de preuve globale (NP1 à NP4, légende ci-dessous) à de nombreux constats de l'argumentaire (épidémiologie, mécanismes). Recherche exhaustive effectuée sur l'intégralité du texte source pour « Grade A », « Grade B », « Grade C » et « accord professionnel » : **aucune occurrence**. À la différence d'autres RFE de ce corpus (Grade 1+/1-/2+/2- ou « accord fort »), ce texte court **n'imprime aucun marqueur de force propre à chaque recommandation** : les NP1-4 qualifient le niveau de preuve d'un constat de l'argumentaire, pas la force d'une recommandation individuelle. Conformément à la règle de ce corpus dans cette situation, **aucun chip de grade n'est fabriqué ici**. Les recommandations reproduites ci-après sont les phrases directives du texte source (« il faut », « il est recommandé de », « il est proposé de », « il ne faut pas », « il n'y a pas lieu de »), présentées avec leur repère de paragraphe d'origine ; lorsque le texte source associe une citation NP à l'énoncé, elle est conservée entre parenthèses à titre de citation de preuve -- jamais comme un grade de recommandation.

Légende des niveaux de preuve (NP) -- argumentaire, PAS un grade de recommandation

Niveau	Définition (méthode GRADE modifiée, comité des référentiels Sfar)
NP1	Preuve globale forte : méta-analyses concordantes de haut niveau, ou étude(s) de haut niveau non contredite(s), ou ≥ 2 études de bas niveau non contradictoires avec $RR > 2$ ou $< 0,5$.
NP2	Preuve globale modérée : ≥ 2 études de bas niveau non contradictoires, mais $RR < 2$ ou $> 0,5$ dans toutes (ou toutes sauf une).
NP3	Preuve globale faible : plusieurs études de bas niveau, dont certaines contradictoires, avec une majorité se dégageant pour un effet favorable ou défavorable.
NP4	Preuve globale très faible : études de haut niveau contradictoires, ou uniquement des études de très bas niveau.

Définitions du document source : réaction allergique = réaction immunologique lors d'un contact renouvelé avec un antigène chez un sujet sensibilisé (période de sensibilisation silencieuse, minimum dix jours) ; anaphylaxie = terme réservé à une réaction grave d'HSI allergique ou non allergique ; atopie = susceptibilité anormale à synthétiser des IgE spécifiques contre des antigènes naturels de l'environnement.

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 1 -- Réalité du risque et substances responsables



Question 1 -- Réalité du risque d'hypersensibilité allergique en anesthésie

Parmi les réactions d'hypersensibilité immédiate (HSI) survenant en anesthésie, environ **60% sont IgE-dépendantes** (réaction allergique) (NP2). Plus de 7000 cas d'HSI IgE-dépendantes péranesthésiques ont été publiés au cours des 25 dernières années (NP2), provenant majoritairement de France, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et, plus récemment, de Scandinavie, grâce à l'organisation mise en place pour le diagnostic et la communication de ces réactions. L'exploration et la déclaration en pharmacovigilance ou matériovigilance des réactions d'HSI doivent être systématiques ; la constitution de réseaux de consultations spécialisées, d'observatoires et de registres doit être encouragée.

Incidence : variable selon les pays, de 1/10 000 à 1/20 000 anesthésies (NP2). Évaluée en France en 1996 à **1/13 000** anesthésies générales et locorégionales, toutes substances confondues. Anaphylaxie aux curares : **1/6500** anesthésies avec curare en France, **1/5200** en Norvège (NP2). **Mortalité** des réactions d'HSI péranesthésiques : **3 à 9%** selon les pays (NP2) ; la morbidité la plus sévère s'exprime par des séquelles anoxiques cérébrales, d'incidence non précisément connue.

Substances responsables -- fréquence relative parmi les cas d'anaphylaxie publiés depuis 1980 (littérature anglaise et française) (NP2)

Substance	Fréquence relative
Curares	62,6 %
Latex	13,8 %
Hypnotiques	7,2 %
Antibiotiques	6 %
Substituts du plasma (colloïdes)	3,2 %
Morphiniques	2,4 %

L'allergie aux anesthésiques locaux apparaît exceptionnelle compte tenu de leur fréquence d'utilisation. **Aucune réaction anaphylactique n'a été publiée avec les anesthésiques halogénés** (NP2). D'autres substances peuvent induire une anaphylaxie péranesthésique : aprotinine, chlorhexidine, protamine, papaïne, héparine, bleu patenté ou de méthylène. Tous les curares peuvent être en cause, y compris dès la première administration ; le curare le plus fréquemment impliqué dans les réactions immédiates allergiques est le **suxaméthonium** (NP2). Une sensibilisation croisée entre curares est possible.

Aspects cliniques : les manifestations sont décrites en quatre grades de gravité croissante (classification adaptée de Ring et Messmer, Tableau 1 du document source). Cette classification en 4 grades de 2011 (seuils : chute de la PA systolique > 30% et tachycardie > 30% pour le grade II) n'est pas retabulée ici : une version actualisée (Ring & Messmer modifiée / CIM-11 OMS, avec seuils chiffrés) est déjà reproduite intégralement dans la fiche compagnon Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf (Champ 4) -- s'y référer pour la classification de référence actuelle. Les manifestations sont souvent plus graves et durables en cas de réaction allergique que non allergique (NP2). Les signes cliniques ne sont pas toujours complets et peuvent prendre des masques trompeurs : l'absence de signes cutanéomuqueux n'exclut pas le diagnostic d'anaphylaxie (NP2). La symptomatologie est habituellement immédiate après l'induction, mais peut être retardée (jusqu'à plus d'une heure) si le latex ou des colorants sont en cause.

Enfant : les substances potentiellement responsables sont les mêmes que chez l'adulte, mais l'allergène le plus fréquemment en cause est le **latex**, en particulier chez l'enfant multiopéré et porteur de spina bifida, ce qui justifie une stratégie de prévention primaire de la sensibilisation au latex (NP1). Les réactions d'hypersensibilité non immédiate impliquant les produits de l'anesthésie sont peu fréquentes ; elles sont surtout décrites avec les anesthésiques locaux (NP2), les antibiotiques, les antiseptiques, les héparines et les produits de contraste iodés ou gadolinés (NP2).

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 2 -- Mécanismes et Question 3 (1/3) -- Bilan biologique



Question 2 -- Mécanismes de la sensibilisation et physiopathologie du choc

La réaction d'HSI allergique est un cas particulier de réaction inflammatoire spécifique d'un allergène reconnu par le système immunitaire. La présentation antigénique oriente la réponse vers des effecteurs de l'allergie (lymphocytes TCD4+ Th1 ou Th2, TCD8+ cytotoxiques, lymphocytes B producteurs d'IgE) ; la tolérance résulterait de la différenciation en lymphocytes T régulateurs (NP2). L'HSI allergique immédiate résulte d'une activation des lymphocytes Th2 et est liée à la production d'IgE ; l'HSI allergique non immédiate est associée à une activation de profil Th1 (production d'IFN-gamma, cytotoxicité) (NP2). Les antigènes médicamenteux sont rarement identifiés : une partie de la molécule (épitope) joue le rôle d'haptène et se lie à une protéine, puis à une molécule du CMH lors de sa digestion par une cellule présentatrice ; un autre mécanisme (« p-i concept ») correspondrait à la liaison non covalente des haptènes avec le CMH ou le récepteur T sans passer par la cellule présentatrice (NP3).

Manifestations cliniques : les réactions allergiques immédiates résultent de l'activation des mastocytes et basophiles par l'allergène reconnu par les IgE fixées à leur surface (NP2). Les médiateurs libérés -- histamine, dérivés de l'acide arachidonique, TNF alpha, enzymes (tryptase notamment) -- altèrent la perméabilité capillaire (urticaire, œdème), provoquent une bronchoconstriction et une chute tensionnelle avec tachycardie (NP1). Les réactions non allergiques (anciennement anaphylactoïdes) résultent d'une activation des basophiles/mastocytes indépendante des IgE et sont de gravité moindre.

Physiopathologie du choc : la première phase correspond à un choc hyperkinétique (tachycardie, effondrement des résistances vasculaires systémiques par vasodilatation artériolaire périphérique, diminution du retour veineux et du débit cardiaque). Puis s'installe un choc hypovolémique hypokinétique, secondaire à l'extravasation plasmatique transcapillaire ; les métabolites de l'acide arachidonique majorent les effets circulatoires par leurs actions sur le muscle lisse vasculaire et les plaquettes (NP2). Un retard au traitement ou une thérapeutique inadaptée peut aboutir à une anoxie tissulaire puis à une défaillance viscérale rendant le choc rapidement réfractaire. **La prise au long cours de bêta-bloquants est un facteur de gravité** (NP1).

Question 3 (1/3) -- Bilan diagnostique : dosages biologiques immédiats

Tout patient présentant une réaction d'HSI péranesthésique doit bénéficier d'une investigation immédiate et à distance (type de réaction, agent causal, sensibilisation croisée éventuelle). L'anesthésiste-réanimateur doit : assurer la mise en œuvre des investigations en partenariat avec une consultation d'allergo-anesthésie ; informer le patient et remettre un courrier détaillé et une carte d'allergie provisoire ; déclarer l'accident au centre régional de pharmacovigilance (médicament suspecté) ou au responsable de matériovigilance de l'établissement (latex suspecté).

La probabilité qu'une symptomatologie clinique soit liée à une HSI est augmentée en présence d'une élévation de la tryptase sérique et de l'histamine plasmatique (NP1), même si une concentration normale n'exclut pas totalement le diagnostic (NP3). Le détail fin des seuils et formules de tryptase/histamine actualisés (formule tenant compte du taux basal, seuils en contexte d'arrêt cardio-respiratoire) est déjà traité dans la fiche compagnon Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf (Champ 1, 2/4) ; les éléments du document 2011, résumés ci-dessous, restent la référence historique de cette question.

Rep.	Recommandation / conduite pratique (source)
S3.3.2.1	Une augmentation franche de la tryptase sérique (> 25 microg/mL) est en faveur d'un mécanisme IgE-dépendant (NP2). Les concentrations restent normales ou peu augmentées dans les réactions cutanéomuqueuses (grade 1) et systémiques modérées (grade 2).
S3.3.2.2	Délais optimaux de prélèvement de la tryptase : 15 à 60 minutes pour les grades 1-2 ; 30 minutes à 2 heures pour les grades 3-4. La positivité excède souvent 6 heures pour les grades sévères (NP3).
S3.3.3.2	Le pic d'histamine plasmatique est observé dès la première minute suivant la réaction (d'autant plus élevé que la réaction est grave), avec une demi-vie d'élimination de 15 à 20 minutes (NP2).
S3.3.3.3	Délai idéal de prélèvement de l'histamine : < 15 min pour le grade 1, < 30 min pour le grade 2, < 2 h pour les réactions plus sévères.
S3.3.3.5	Il ne faut pas doser l'histamine plasmatique chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre (synthèse placentaire de diamine oxydase) ni chez les patients sous héparine (augmentation de diamine oxydase proportionnelle à la dose).
S3.5.4	En cas de décès, les prélèvements pour tryptase et IgE spécifiques doivent être pratiqués avant l'arrêt de la réanimation plutôt qu'en post-mortem (NP4) ; le prélèvement fémoral est recommandé (NP3).

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 3 (2/3, 3/3) et 4 -- tests, facteurs de risque, bilan préop

IgE spécifiques : un taux d'IgE totales n'a aucune pertinence diagnostique. La recherche d'IgE spécifiques concerne principalement les ammoniums quaternaires (curares), le thiopental, le latex, les bêta-lactamines et la chlorhexidine (NP2). L'IgE anti-ammonium quaternaire reste détectable plusieurs années après une réaction à un curare (NP1) ; les techniques à privilégier sont le SAQ-RIA ou le PAPPC-RIA (NP2). Les techniques de dosage des IgE spécifiques du latex ont une excellente sensibilité (NP2). Seuls quelques antibiotiques sont dosables (pénicilloyl G et V, amoxicilloyl, ampicilloyl, céfclor) ; il ne faut pas les rechercher à titre systématique, et seul l'allergologue en charge du bilan est habilité à demander et interpréter ces dosages, compte tenu de leur sensibilité faible (NP2).

Tableau 2 (source) -- modes et délais de prélèvement sanguin pour les dosages d'histamine, de tryptase et d'IgE anti-ammonium quaternaire (AQ)

Dosage	Tube	Prélèvement < 30 min	Prélèvement 1 à 2 h	Prélèvement > 24 h
Histamine	EDTA	+	(+)	
Tryptase	EDTA / sec	+	+	+
IgE anti-AQ	Sec	+	(+)	(+)

+ : recommandé ; (+) : si non réalisé au moment de la réaction.

Modalités de prélèvement (S3.5.1) : histamine sur tube EDTA (5 mL) ; tryptase sur tube sec ou EDTA (le même tube EDTA peut servir aux deux dosages) ; IgE sur tube sec (7 mL). Transmission au laboratoire dans les 2 heures, sinon conservation à +4°C pendant 12 h maximum ; après centrifugation, plasma et sérum congelés à -20°C en aliquotes, le plasma étant recueilli à distance de la couche leucocytaire (NP2). Du fait de la gravité potentielle et de la demi-vie courte de certains médiateurs, il est conseillé de disposer au bloc opératoire d'un sachet contenant les tubes de prélèvement, le protocole de recueil et la fiche de collecte des données cliniques.

Question 3 (2/3) -- Tests cutanés : PT / IDR (référence diagnostique)

Délai (S3.6.1) : les tests cutanés doivent être effectués **4 à 6 semaines** après la réaction, pour permettre la reconstitution des médiateurs dans les basophiles et mastocytes (NP3). En cas de nécessité, ils peuvent être réalisés plus précocement, mais cela accroît le risque de faux négatifs et seuls les résultats positifs sont alors pris en compte -- ce bilan précoce ne se substitue pas au bilan réalisé après 4 à 6 semaines (NP4).

Le diagnostic d'HSI repose sur l'association des signes cliniques, le dosage des médiateurs et un bilan allergologique à distance (tests cutanés, tests de laboratoire, éventuellement tests de provocation). Les tests cutanés ne peuvent être interprétés qu'en fonction de renseignements cliniques chronologiques et détaillés fournis par l'anesthésiste, idéalement avec copie de la feuille d'anesthésie et de SSPI ainsi que les résultats de tryptase/histamine. Conditions requises : consentement éclairé ; arrêt préalable des médicaments inhibant la réactivité cutanée (antihistaminiques, psychotropes) (NP2). Grossesse, jeune âge, bêta-bloquants (sauf pour les bêta-lactamines), corticoïdes oraux ou IEC ne sont **pas** des contre-indications aux tests cutanés (NP3). Il est recommandé de tester l'ensemble des médicaments du protocole anesthésique, le latex et les autres produits périnanesthésiques ; le choix se fait par le binôme allergologue-anesthésiste lors de la consultation d'allergo-anesthésie.

Technique : solutions commerciales pures ou diluées extemporanément (sérum physiologique ou phénolé). La valeur prédictive des PT est inférieure à celle des IDR (NP4). Quand les PT sont négatifs, les IDR débutent à une dilution au 1/1000e (curares) ou 1/10 000e (morphine) de la solution mère ; si l'IDR est négative, la concentration suivante (x10) est utilisée, avec un intervalle de 20 minutes entre chaque test, sans dépasser les concentrations maximales des Tableaux 3 et 4 (NP1). En cas de réaction de grade IV, le médicament suspecté est testé dès le prick-test à partir du 1/100e de la solution mère. L'interprétation exige un témoin négatif et un témoin positif (phosphate de codéine 9% et/ou histamine 10 mg/mL, œdème $\geq$ 3 mm à 20 min) (NP2). Positivité du PT : œdème de diamètre supérieur de 3 mm au témoin négatif, ou $\geq$ à la moitié du diamètre du témoin positif (NP2). Positivité de l'IDR : papule obtenue de diamètre au moins double de la papule d'injection, à 20 minutes (NP2).

Site des tests (S3.6.8.8) : le site de réalisation des tests cutanés (dos, bras ou avant-bras) est indifférent à condition que l'interprétation du résultat tienne compte de la réactivité normale de la peau au site de réalisation du test et de la taille de la papule d'injection intradermique du produit à tester (NP2). **Volume d'injection des IDR (S3.6.8.10)** : il faut réaliser les IDR en injectant dans le derme un volume de 0,03 à 0,05 mL de la solution commerciale diluée, afin d'obtenir une papule d'injection (PI) ayant au maximum 4 mm de diamètre.

Tableaux 3 et 4 du document source (ci-dessous, reproduits verbatim) : concentrations normalement non réactives (C = concentration de la solution commerciale ; PT/IDR Dilution = dilution testée ; CM = concentration maximale à ne pas dépasser pour éviter les faux positifs).

Tableau 3 -- Agents anesthésiques

DCI	Nom commercial	C (mg/mL)	PT Dilution	PT CM (mg/mL)	IDR Dilution	IDR CM (mg/mL)
Atracurium	Tracrium	10	1/10	1	1/1000	10
Cis-atracurium	Nimbex	2	Non dilué	2	1/100	20

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 3 (2/3, 3/3) et 4 -- tests, facteurs de risque, bilan préop



DCI	Nom commercial	C (mg/mL)	PT Dilution	PT CM (mg/mL)	IDR Dilution	IDR CM (mg/mL)
Mivacurium	Mivacron	2	1/10	0,2	1/1000	2
Pancuronium	Pavulon	2	Non dilué	2	1/10	200
Rocuronium	Esmeron	10	Non dilué	10	1/200	50
Suxaméthonium	Célocurine-klorid	50	1/5	10	1/500	100
Vécuronium	Norcuron	4	Non dilué	4	1/10	400
Étomidate	Hypnomidate / Étomidate-Lipuro	2	Non dilué	2	1/10	200
Midazolam	Hypnovel	5	Non dilué	5	1/10	400
Propofol	Diprivan	10	Non dilué	10	1/10	1000
Thiopental	Nesdonal	25	Non dilué	25	1/100	250
Kétamine	Ketalar	100	1/10	10	1/100	1000
Alfentanil	Rapifen	0,5	Non dilué	0,5	1/10	50
Fentanyl	Fentanyl	0,05	Non dilué	0,05	1/10	5
Morphine	Morphine	10	1/10	1	1/1000	10
Rémifentanyl	Ultiva	0,05	Non dilué	0,05	1/10	5
Sufentanil	Sufentanyl	0,005	Non dilué	0,005	1/10	0,5
Bupivacaïne	Marcaïne	2,5	Non dilué	2,5	1/10	250
Lidocaïne	Xylocaïne	10	Non dilué	10	1/10	1000
Mépivacaïne	Carbocaïne	10	Non dilué	10	1/10	1000
Ropivacaïne	Naropéine	2	Non dilué	2	1/10	200

Tableau 4 -- Antiseptiques et colorants

DCI	Nom commercial	C (mg/mL)	PT Dilution	PT CM (mg/mL)	IDR Dilution	IDR CM (mg/mL)
Antiseptiques						
Chlorhexidine aqueuse non colorée	--	0,5	Non dilué	0,5	1/10	50
Povidone iodée aqueuse	--	100	Non dilué	10	1/10	10 000
Colorants						
Bleu patenté	--	25	Non dilué	25	1/10	2500
Bleu de méthylène (chlorure de méthylthionine)	--	10	Non dilué	10	1/100	100

Pour les tests intradermiques aux colorants, risque de tatouage persistant plusieurs mois.

Autres points (S3.6.8.11 à S3.6.8.15) : il faut rechercher une sensibilisation croisée avec tous les autres curares commercialisés en cas de positivité à un curare (NP2), y compris avec les curares nouvellement commercialisés après une réaction anaphylactique prouvée lors d'une anesthésie antérieure (NP3). En cas de réaction survenant plus de 24 heures après l'anesthésie, il est recommandé de réaliser des tests épicutanés (patch-tests) à lecture retardée (≥ 48 h), notamment pour une symptomatologie à type d'eczéma : antibiotiques, produits de contraste iodés, allergènes de contact (métaux, caoutchouc, colorants, antiseptiques) (NP3). Il faut exclure le terme « douteux » des comptes rendus : la réponse est binaire (positif/négatif), à refaire à distance si nécessaire (NP4). La performance des tests cutanés peut décroître avec le temps -- prolongée avec les curares, elle décroît avec les antibiotiques (NP2).

Question 3 (3/3) -- Tests cellulaires, tests de provocation, résultats

Tests cellulaires (histaminolibération, test d'activation des basophiles par cytométrie en flux, libération des leucotriènes leucocytaires) : aucun n'a démontré de supériorité franche sur les autres ; ils sont prescrits selon l'expertise du laboratoire, en complément des tests cutanés (pas en remplacement), inutiles si le diagnostic est déjà établi. Indications : réaction de grade $\geq$ II avec tests cutanés négatifs à tous les produits suspectés ; tests cutanés difficilement interprétables (dermographisme, sujet très âgé ou très jeune, atopique avec lésions cutanées étendues, prise d'antihistaminiques) ; confirmation du choix d'un curare dont le test cutané est négatif ; pour l'hypersensibilité aux AINS, cytométrie en flux ou libération de leucotriènes. Le protocole actualisé du test d'activation des basophiles (délai minimal, arrêt des corticoïdes) est détaillé dans la fiche compagnon Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf (Champ 1, 3/4).

Tests de provocation / réintroduction : indications restreintes -- médicaments à tests cutanés négatifs (anesthésiques locaux, antibiotiques, exceptionnellement latex) ou non validés/impossibles (AINS), ou allergène indisponible sous forme réactive (métabolites, pénicillines à tests cutanés négatifs, autres antibiotiques, AINS) (NP2). Réalisés au moins 1 mois après la réaction, avec le même médicament et la même voie, sous haute surveillance, uniquement en centres spécialisés avec accès à un secteur de soins intensifs

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 3 (2/3, 3/3) et 4 -- tests, facteurs de risque, bilan préop



(NP1) ; consentement éclairé et rapport bénéfice/risque favorable préalables (NP3). **Réintroduction des anesthésiques locaux** : 0,5 à 1 mL de solution non diluée et non adrénalinée en sous-cutané ; négatif en l'absence de réaction dans les 30 minutes ; chez la parturiente, en salle de naissance, 30 minutes avant la technique périmédullaire, équipe obstétricale prévenue (NP4) -- protocole pour l'essentiel inchangé dans la mise à jour de 2025 (voir fiche dédiée, R3.4.2/Annexe 6). **Test de provocation au latex** : port d'un gant en latex naturel riche en protéines, non poudré, pendant 15 minutes ; négatif en l'absence de signe d'HSI dans les 30 minutes (NP3).

Résultats de l'enquête et traçabilité : le compte rendu de l'allergologue est adressé à l'anesthésiste prescripteur et figure au dossier médical ; un double est adressé au centre régional de pharmacovigilance (avec le descriptif clinique) et au médecin traitant. À la fin de la consultation d'allergo-anesthésie, une lettre détaillée et une carte d'allergie définitive sont remises au patient, qui est encouragé à les porter près de ses papiers d'identité (port de bracelet ou médaille également encouragé). En cas de difficulté d'interprétation, le recours à un groupe régional ou local d'allergologues et d'anesthésistes-réanimateurs référents est souhaitable (liste disponible via les sites Sfar et SFA). Il est souhaitable de suivre régulièrement l'évolution du nombre de réactions d'HSI, en colligeant les données des centres référents et de pharmacovigilance régionale, situées dans le cadre des enquêtes de mortalité-morbidité de la Sfar ou du GERAP.

Question 4 -- Facteurs favorisant et place du bilan allergologique péranesthésique

Patients à risque de réaction d'hypersensibilité (S4.1)

Rep.	Recommandation / conduite pratique (source)
S4.1.1	Diagnostic d'allergie à un médicament/produit de l'anesthésie déjà établi par un bilan allergologique préalable.
S4.1.2	Signes cliniques évocateurs d'une allergie lors d'une précédente anesthésie.
S4.1.3	Manifestations cliniques lors d'une exposition au latex (NP2), quelles que soient les circonstances d'exposition.
S4.1.4	Enfants multiopérés, notamment pour spina bifida ou myéloméningocèle (fréquence élevée de sensibilisation au latex, NP1, et d'HSI au latex, NP1).
S4.1.5	Manifestations à l'ingestion d'avocat, kiwi, banane, châtaigne, sarrasin, etc., ou exposition au Ficus benjamina (fréquence élevée de sensibilisation croisée avec le latex, NP2).

Non recommandé / absence de justification -- dans la population générale, il n'y a pas lieu de pratiquer avant une anesthésie un dépistage systématique d'une sensibilisation aux médicaments/produits utilisés en anesthésie (S4.2.2) : les valeurs prédictives positive et négative des tests dans la population générale ne sont pas suffisamment connues, et une valeur faussement positive peut avoir des conséquences néfastes (changement de technique non nécessairement adapté) -- le rapport bénéfice/risque d'un tel dépistage est inconnu. De même, chez les patients atopiques ou allergiques à un médicament non utilisé en anesthésie, il n'y a pas lieu de rechercher une sensibilisation aux produits anesthésiques (S4.2.3).

Chez les patients à risque définis ci-dessus, il faut proposer des investigations allergologiques avant toute anesthésie (S4.2.4) ; au-delà de 6 mois après la réaction, le risque de faux négatif existe. **Investigations** : patients S4.1.1 -- conserver les conclusions du bilan antérieur, tester les curares nouvellement commercialisés en cas d'allergie aux curares ; patients S4.1.2 -- en situation réglée, rechercher le protocole suspect et le transmettre à l'allergologue (protocole inconnu : tester tous les curares et le latex ; protocole identifié : tester les médicaments du protocole ancien et le latex, avec test de réintroduction pour les anesthésiques locaux après tests cutanés négatifs) ; en situation d'urgence, exclure le latex de l'environnement et utiliser une anesthésie locorégionale ou générale évitant curares et histaminolibérateurs (NP4) ; patients S4.1.3-S4.1.5 -- pricks au latex + IgE spécifiques du latex.

Situations particulières et demande de bilan allergologique (S4.3) -- contenu propre au document 2011, non repris dans la fiche compagnon 2025

Situation	Conduite pratique (source)
HSI suspectée à un AINS non sélectif	Non urgent : bilan allergologique hospitalier avec tests de réintroduction réalistes. Urgence : pas d'anti-COX-1 ; anti-COX-2 utilisables (célécoxib, parécocixib) ; paracétamol possible à dose réduite (effet anti-COX-1 à fortes doses) (NP2).
HSI suspectée au paracétamol	Intervention non urgente : bilan en milieu hospitalier spécialisé avec tests de réintroduction réalistes.
Réaction à la morphine ou à la codéine	Ne pas réinjecter morphine ou codéine ; tous les autres morphiniques sont utilisables.
Allergie alimentaire à l'œuf ou au soja	Propofol utilisable chez l'allergique à l'œuf (un seul cas rapporté) ; l'huile purifiée de soja de l'excipient ne contre-indique pas le propofol en cas d'allergie au soja (NP4).

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 3 (2/3, 3/3) et 4 -- tests, facteurs de risque, bilan préop



Situation	Conduite pratique (source)
Allergie aux fruits de mer ou au poisson	L'allergène en cause n'étant pas l'iode, médicaments et badigeons iodés ne sont pas contre-indiqués (NP3).
Allergie documentée à la protamine	Contre-indication à la protamine. Un cas rapporté chez un allergique au poisson, mais une revue récente de la littérature ne justifie pas son éviction en cas d'allergie au poisson (NP2).

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 5 et 6 (résumé) -- prévention, technique et traitement



Question 5 -- Prévention primaire et secondaire. Prémédication et technique anesthésique

Cette question est le cœur de cette fiche : c'est le volet du document 2011 que la fiche compagnon *Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf* déclare elle-même hors de son propre champ (« reste du Champ 3 -- prévention programmée »).

Prévention primaire (S5.1)

Rep.	Recommandation / conduite pratique (source)
S5.1.1-2	La prévention primaire d'une sensibilisation correspond à la non-exposition au médicament ou au matériau. Impossible pour les agents anesthésiques, mais réalisable pour certains matériaux comme le latex ; l'administration des curares doit être raisonnée, selon les indications de la curarisation (NP4).
S5.1.3	Il faut éviter l'exposition des patients au latex pour diminuer le risque de sensibilisation. La décision institutionnelle de travailler en ambiance « latex-free » est une prévention primaire efficace (NP1).

Prévention secondaire (S5.2)

Rep.	Recommandation / conduite pratique (source)
S5.2.1	La meilleure prévention secondaire est la non-administration du médicament auquel le sujet est sensibilisé ; il faut déterminer l'allergène responsable pour éviter une récurrence lors d'une utilisation ultérieure (NP2).
S5.2.2	Facteurs de risque de sensibilisation au latex : terrain atopique, exposition professionnelle ou non répétée au latex, malformations urinaires (spina bifida, vessie neurologique, etc.), malformations justifiant de multiples interventions.
S5.2.3	Les patients sensibilisés au latex doivent être inscrits en première position sur le programme opératoire, dans un environnement exempt de latex ; il faut notifier la sensibilisation pendant tout le séjour hospitalier (service, bloc, SSPI) (NP3).
S5.2.4	On peut utiliser un questionnaire préopératoire pour dépister la sensibilisation au latex lors de la consultation préanesthésique, ce qui pourrait réduire l'incidence des réactions au latex (NP4).
S5.2.5	En cas de suspicion de sensibilisation au latex, il faut adresser le patient en consultation d'allergologie en préopératoire (NP3).
S5.2.6	Il faut établir des listes, régulièrement mises à jour, des matériels contenant du latex dans chaque service d'anesthésie-réanimation, en collaboration avec la pharmacie (NP3).
S5.2.7	Il ne faut pas faire de recherche systématique préanesthésique d'une sensibilisation en dehors des patients à risque (NP2).
S5.2.8	Il faut adresser en consultation d'allergologie, avant une anesthésie, les patients à risque de réaction allergique aux médicaments/matériaux périopératoires : réaction inexpliquée à un allergène non identifié lors d'une anesthésie antérieure, ou sujets allergiques connus à une classe de médicaments à utiliser, ou à risque d'allergie au latex.
S5.2.9	Il ne faut pas utiliser la méthode de la dose-test par voie intraveineuse pour détecter les sujets sensibilisés aux médicaments anesthésiques (NP4).

Prémédication (S5.3)

Non recommandé / absence de justification -- aucune prémédication n'est efficace pour prévenir une réaction d'HSI allergique (S5.3.1). L'administration préalable d'un antihistaminique peut diminuer l'incidence et l'intensité des réactions d'HSI **non allergiques** (NP2), mais l'association d'un anti-H1 à un anti-H2 n'a pas montré de supériorité à l'anti-H1 seul (NP3). Il n'existe pas de preuve d'efficacité, en administration unique, de la prémédication par corticoïdes pour prévenir une réaction d'HSI (NP4) -- chez l'asthmatique sous corticoïdes au long cours, ceux-ci diminuent l'incidence de l'hyperréactivité bronchique per-anesthésique (NP3).

Convergence avec la fiche compagnon 2025 : cette conclusion de 2011 (pas de prémédication antihistaminique/corticoïde systématique) rejoint celle, 14 ans plus tard, de *Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf* (R3.5) -- « il n'est probablement pas recommandé de prescrire systématiquement une prémédication (antihistaminiques, corticoïdes) aux patients à risque de réaction d'HSI péri-opératoire, hors mastocytose ».

Anesthésie des patients allergiques ou susceptibles de l'être (S5.4)

Rep.	Recommandation / conduite pratique (source)
S5.4.1	Il est recommandé d'administrer l'antibioprophylaxie préopératoire au bloc, chez un patient monitoré et éveillé, avant l'induction : l'imputabilité de l'antibiotique est plus facile à déterminer et la réanimation, sans médicament cardiovasculaire déjà reçu, est plus facile (NP4).

Prévention du risque allergique péranesthésique

Question 5 et 6 (résumé) -- prévention, technique et traitement



Rep.	Recommandation / conduite pratique (source)
S5.4.2	Le choix de la technique se fait selon le sujet et l'acte. En urgence, en l'absence de bilan allergologique, il faut privilégier les techniques locorégionales et les techniques générales évitant curares et histaminolibérateurs, en environnement sans latex (NP3).
S5.4.3	Le choix des agents se fait selon les données anamnestiques et les résultats du bilan allergologique (NP2) : les halogénés n'ont jamais été incriminés dans une HSI ; l'allergie au propofol et aux benzodiazépines est exceptionnelle ; les réactions aux opiacés (morphine, codéine) sont le plus souvent non allergiques ; tous les curares peuvent induire une HSI allergique -- le choix se fait selon l'indication de la curarisation et les tests cutanés (NP3). En cas d'HSI allergique à un curare, il faut rechercher systématiquement une sensibilité croisée avec les autres curares disponibles pour proposer un curare pour les interventions ultérieures (NP3).

Question 6 -- Traitement des réactions d'hypersensibilité immédiates (résumé et renvoi)

Résumé (document 2011) : mesures générales dans tous les cas -- arrêt du produit suspecté, information de l'équipe chirurgicale, oxygène pur (NP4). Grade I : mesures générales généralement suffisantes. Grades II-III : oxygénation, contrôle des voies aériennes, **adrénaline IV titrée** (10 à 20 microg pour le grade II, 100 à 200 microg pour le grade III, renouvelable toutes les 1 à 2 minutes jusqu'à PAM $\geq$ 60 mmHg ; voie IM 0,3-0,5 mg si absence de voie veineuse), remplissage vasculaire rapide par cristalloïdes (colloïdes si volume $>$ 30 mL/kg), salbutamol inhalé ou IV en cas de bronchospasme, glucagon en cas de choc réfractaire chez un patient sous bêta-bloquants. Grade IV (arrêt cardiaque) : massage cardiaque, adrénaline 1 mg toutes les 1 à 2 minutes, mesures habituelles de réanimation. Seconde intention : corticoïdes pour atténuer les manifestations tardives, surveillance intensive $\geq$ 24 heures. Particularités décrites chez la femme enceinte (décubitus latéral gauche, extraction fœtale dès 25 SA si échec de réanimation à 5 minutes) et chez l'enfant (adrénaline 10 microg/kg en arrêt circulatoire, cristalloïdes 20 mL/kg puis colloïdes 10 mL/kg).

Renvoi explicite : cette section est volontairement résumée. Le corpus de ce site contient une fiche dédiée et bien plus récente, **Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf** (RFE Sfar/SFA, Champ 4), qui détaille l'algorithme de traitement actualisé -- classification de gravité Ring & Messmer modifiée/CIM-11 OMS, posologies d'adrénaline par grade (IV, IVSE, IM), remplissage vasculaire, prise en charge du choc réfractaire (noradrénaline, bleu de méthylène, argipressine, ECLS) et annexe 7 (algorithme visuel de synthèse). Les principes de 2011 (adrénaline IV titrée, mêmes seuils de dose pour les grades II-III, remplissage par cristalloïdes) restent globalement cohérents avec les recommandations actualisées de 2025, qui les précisent. **Se référer à la fiche dédiée pour la prise en charge aiguë du choc anaphylactique.**

Sources et traçabilité

Document source : Malinovsky JM (président), Baillard C, Radu D (chargés de projet), et le comité d'organisation et les groupes de travail Sfar/SFA -- « Prévention du risque allergique péranesthésique. Texte court », Recommandations formalisées d'experts, Société française d'anesthésie et réanimation (Sfar) & Société française d'allergologie (SFA). Ann Fr Anesth Réanim 2011;30:212-222.

Publication : doi:10.1016/j.annfar.2010.12.002. Actualisation des recommandations Sfar/SFAIC élaborées en 2001 et publiées en 2002.

Méthodologie : méthode GRADE modifiée, agréée par le comité des référentiels de la Sfar -- quatre niveaux de preuve globale NP1 (forte) à NP4 (très faible) attachés aux constats de l'argumentaire. Recherche exhaustive de « Grade A/B/C » et « accord professionnel » sur l'intégralité du texte source : aucune occurrence. En l'absence de tout marqueur de force par recommandation, cette fiche reproduit les phrases directives du texte source avec leur repère de paragraphe d'origine, sans grade fabriqué (voir panneau méthodologique en page 1).

Couverture : questions 1 à 5 reproduites intégralement (réalité du risque et substances responsables, mécanismes et physiopathologie, bilan diagnostique biologique et cutané -- Tableaux 2, 3 et 4 reproduits verbatim --, facteurs favorisants et bilan préanesthésique avec situations particulières, prévention primaire/secondaire -- prémédication -- choix de la technique anesthésique). Question 6 (traitement) résumée avec renvoi explicite vers Fiche_SFAR_Anaphylaxie_2025.pdf, qui la traite intégralement et de manière plus actuelle. La classification de gravité en 4 grades (Tableau 1 du document source, variante 2011 de Ring & Messmer) n'est pas retabulée : une version actualisée est déjà reproduite intégralement dans cette même fiche compagnon (Champ 4).

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les questions 1 à 5 du texte court et résume la question 6 avec renvoi vers une fiche compagnon plus récente, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, annexes I à V) et n'est ni éditée ni validée par la Sfar ou la SFA. Document de 2011 : plusieurs éléments (tests cellulaires, dosages biologiques, classification de gravité) ont été précisés par la RFE Sfar/SFA plus récente sur l'hypersensibilité immédiate péri-opératoire (voir fiche dédiée de ce site). En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.